

广西壮族自治区医疗保障局

桂医保函〔2026〕262号

自治区医保局关于做好挂网药品价格风险 预警标识管理工作的通知

各市、县（市、区）医保局，自治区医疗保障事业管理中心（自治区医疗保障基金监管事务中心）、自治区医药价格和招标采购服务中心，区直及解放军、武警部队驻桂医疗机构：

为全面落实《国家医疗保障局办公室关于2026年深化医药价格治理重点工作的通知》（医保办函〔2025〕139号）、《关于落实挂网药品价格风险预警标识的通知》（医保价采函〔2026〕2号）等工作部署，严格执行《广西壮族自治区医药采购平台药品挂网规则》相关规定，持续深化医药价格常态化治理，规范全区公立定点医疗机构药品采购行为，遏制“采高不采低”突出问题，切实减轻群众医药费用负担，现就做好全区挂网药品价格风险预警标识管理工作通知如下。

一、明晰标识标准，规范双色分级

（一）统一标识展示样式

依托医疗保障信息平台药品和医用耗材招采管理子系统（以下简称“招采子系统”），落实可视化、差异化风险标识管理，

对同组药品挂网价格相对较高的品种，设立“黄标”“红标”两级价格风险预警标识，向医疗机构提示价格风险。其中，标注“黄标”的为存在一定价格风险的药品，在招采子系统以黄色背景展示，采购操作时弹窗提示“同通用名药品有其他较低价产品”，引导医疗机构择优采购；标注“红标”的为存在严重价格风险的药品，在招采子系统以红色背景展示，采购操作时弹窗提示“该企业本药品存在价格风险，同通用名药品有其他企业低价产品，请慎重采购”，提醒采购环节审慎选用。

（二）分类设置预警阈值

严格按照我区医药采购平台药品挂网规则以及药品差比价规则总体原则，结合药品剂型规格、质量层次、集采落地等情况统筹划定红黄标价格判定基准，依托招采子系统实现自动识别标注。一是区分药品品类锚定价格区间，按照化学药、中成药、生物类似药等不同品类设置差异化价格风险倍数标准，同步结合集采落地与否调整价格参照基准；二是落实差异化豁免管理要求，对协议期内的医保目录谈判药品，国家和自治区短缺药品清单、临床必需易短缺药品重点监测清单内的药品等临床刚需特殊品类，以及单价低廉的小规格制剂，暂不纳入红黄标标注范围；三是从严管控极端高价药品，在市场竞争充分、供应稳定的情况下，对超过参照价格 10 倍的药品进行撤销挂网、暂停挂网处理，督促企业全面调整报价。

（三）动态更新红黄标识

药品生产企业主动消除价格风险的，招采子系统同步动态调整对应红黄标标识，实现标识状态实时更新。自治区医药价格和招标采购服务中心定期开展招采子系统挂网价格全面校验，结合医药企业自主调价、集采批次落地、短缺药品清单和临床必需易短缺药品重点监测清单更新等各类情形，同步更新全区红黄标药品清单。各级医保部门定期通过招采子系统挂网目录查询药品警示标识，及时掌握价格风险药品情况。

二、划定监测口径，明确预警红线

（一）明确监测范围口径

全区所有定点公立医疗机构全部纳入红黄标药品常态化监测范围，监测核算对象为招采子系统中标注红黄标的全部挂网药品。“红标”（或“红黄标”）药品实际采购金额（按配送金额进行统计，下同）占比按医疗机构所有药品采购总金额计算，即医疗机构“红标”（或“红黄标”）药品实际采购金额占比=医疗机构采购所有“红标”（或“红黄标”）药品总金额÷该医疗机构所有药品采购总金额。药品采购金额统一剔除中药饮片、中药配方颗粒（纳入集采范围的品种除外）、毒麻精放特殊管理等药品，相关品类采购金额暂不纳入红黄标占比测算。后续国家医保局如有新规定的，按新的规定调整执行。

（二）严格监测执行标准

挂网药品价格风险预警标识管理为国家医保局深化医药价

格治理重点工作，全国统一制度规则和监管尺度。我区严格统一执行国家规范监测判定标准，以医疗机构每季度在招采子系统内的药品实际采购金额占比作为考核依据，一是单季度红标药品采购金额占该医疗机构全部药品采购金额的占比超过 10%，二是单季度红黄标药品累计采购金额占该医疗机构全部药品采购金额的占比超过 25%，采购指标达到任一管控界限即启动采购行为预警处置。因突发公共卫生事件、药品供应短缺等客观原因造成医疗机构指标超标的，经所在统筹区医保部门核实后，相关药品采购数据可不纳入该季度考核范围。

（三）规范数据提取路径

自治区医药价格和招标采购服务中心按月梳理全区药品整体采购数据，形成全区药品红黄标采购监测报表，为全区统筹监测管理提供数据支撑。各统筹区医保部门定期登录招采子系统综合监管功能板块，依托“药品红黄标管理”专属模块，按月自主导出本统筹区医疗机构红黄标药品采购金额、占比统计台账。

三、分级处置流程，压实整改闭环

（一）月度监测预警提醒

自 2026 年第 4 季度起全面实施月度常态化数据统计机制，各统筹区医保部门定期筛查本统筹区各医疗机构红黄标采购占比情况，及时对指标临近预警管控线的医疗机构进行点对点风险提示，提前指导医疗机构优化院内药品采购目录，从源头防范超标问题发生。

（二）季度分级分类处置

每季度结束后，各统筹区医保部门向指标超标的医疗机构推送异常采购数据，督促医疗机构限期提交情况说明、制定整改措施，并按照医疗机构超标严重程度实施相应的管控举措。一是针对单项指标触发预警，但能够提供重症救治、专科特殊诊疗等完整合理临床佐证材料（如药事管理委员会意见、临床适应症说明、无替代品种说明及重点病例简要记录等）的医疗机构，采取口头提醒方式督促规范采购，并妥善留档保存相关材料；无正当理由出现单项超标问题的，同步下达书面整改通知书，约谈医疗机构药品管理负责人。二是针对单季度红标、红黄标两项指标同步触发预警且无合规临床依据的医疗机构，下发书面整改通知书，约谈医疗机构分管药品管理负责人，并将该医疗机构纳入下一季度重点监测名单，按月持续跟踪采购数据变化。三是针对连续两个季度触发预警阈值、整改后指标未见明显回落、以虚构理由规避监测管理等医疗机构，约谈医疗机构主要负责人，将相关监测结果纳入定点医疗机构年度医保履约考核，依规扣减对应考核分值，必要时可在一定范围内进行通报。

（三）规范台账留存管理

各统筹区医保部门建立规范完整的红黄标预警处置台账，详细记录超标机构名称、异常采购占比、触发预警标准、对应处置措施、整改时限、整改情况等信息（详见附件），分类整理归档妥善保管，做好资料留存备查工作。

四、细化工作举措，强化统筹保障

（一）压实层级管理责任

各级医保部门要加强对挂网药品价格风险预警标识管理，进一步规范全区公立定点医疗机构药品采购行为。自治区医保部门负责招采子系统红黄标标识维护、全区数据汇总、系统技术支撑等工作，并对区直及解放军驻邕三级医疗机构各类异常采购行为进行处置。各统筹区医保部门负责相应统筹区内公立定点医疗机构日常数据监测、约谈通报、整改跟踪、台账归档等全流程处置工作。各相关单位须明确专职工作人员负责此项工作，确保各层级监测管理责任落地落细。

（二）坚持分类精准施策

工作推进全程杜绝简单化、“一刀切”管理模式，要充分兼顾临床用药专业性、特殊性，以及不同医疗机构功能定位与临床诊疗实际。一是针对基层医疗机构采购规模偏小、数据易出现小幅波动的情况，实行差异化监测标准，侧重政策宣讲与业务指导；二是针对医疗机构承担疑难危重症救治、专项保健任务确需采购红黄标高价药品的，医疗机构可完整留存临床使用佐证材料，统筹区医保部门核查属实后可豁免相关处置措施；三是所有监测处置工作充分尊重临床合理用药客观需求，以政策引导优化采购结构为主，不单纯依靠行政管控约束临床诊疗。

（三）强化多方协同联动

各地医保部门要压紧压实辖区内医药企业价格管理主体责任

任，引导医药企业主动下调虚高挂网价格，从源头消除红黄标价格风险。要将挂网药品价格风险预警标识管理与医保基金管理突出问题专项整治、纠正医药购销领域和医疗服务中不正之风等工作深度融合、统筹部署、一体推进，对问题突出、整改不力的医疗机构，必要时可将有关问题线索按程序移交相关部门进一步核查处置。工作推进过程中如发生多家医疗机构持续性严重超标、大规模违规采购等典型案例情况，须第一时间向自治区医保局专项报告，严禁迟报、漏报、瞒报。

附件：挂网药品价格风险预警工作情况登记表

广西壮族自治区医疗保障局

2026年9月3日

（公开前需经政府信息公开审查）

附件

挂网药品价格风险预警工作情况登记表

所属季度：XXXX 年第 X 季度

序号	定点医疗机构名称	机构等级	异常采购情况	触发标准	原因	处置措施	整改情况	备注
例 1	AAA 医院	一级	“红标”药品采购金额占比 12%	“红标” >10%		X 月 X 日进行口头提醒…	已完成整改。整改措施：1. 2. 3.	
例 2	BBB 医院	二级	“红黄标”累计金额占比 27%	“红黄标”累计 >25%		X 月 X 日进行口头提醒…	已完成整改。整改措施：1. 2. 3.	
例 3	CCC 医院	三级	“红标”药品采购金额占比 15%、“红黄标”累计金额占比 32%	两项均触发		X 月 X 日进行书面通报提醒；X 月 X 日约谈主要负责人…	已完成整改。整改措施：1. 2. 3.	
…								